



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT
(PKRS)
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nomor : 823.3/I-PDM/DIR/IX/2025

Tentang
Pedoman Kerja Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Disusun oleh :

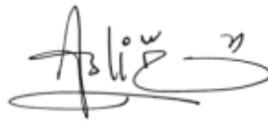
Ketua



drg. Endy Pradana, M.MRS

Disetujui oleh :

Authorized Person



Dr. dr Aslichah M.Kes., AFP

Ditetapkan oleh :

Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Kerja Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada.

Pedoman Kerja Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2022 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah MMRS AFP

PELAKSANA

1. dr. drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
2. Mukhammad Eriko Firdaus, S.Kom
3. Mayputri Nabilla, A.Md.Kes
4. Indah Maulhayati, S. Kep. Ns
5. Dyah Kusuma Wardani, Amd. Kep
6. Wibowo Krisdianto, Amd.Kep
7. Ferianto Hendri Cahyono, Amd.Kep
8. Elok Lonchat Okyani, S.Kep.Ns
9. Daning Pravita, S.Tr., Keb
10. Apt. Susanti, S.Farm
11. Rizky Esa Wisnu Wardana, S. Kep. Ns
12. Putri Adi Ramadhania, Amd. Keb
13. Rista Alfia Sari, Amd. Kep
14. Ni Made Dyah Ayu Sawitri, S. Tr. Kep. Ns
15. Saghita Puspita Sari, Amd. Kep
16. Nafisah Ulfa Hasanah, S. Gz
17. Fitri Octavia, Amd. Kep
18. Mike Maulina, S. Kep. Ns
19. Nabila Riski Amalia, S.Tr. Kes

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR..... Error! Bookmark not defined.

TIM PENYUSUN Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN..... Error! Bookmark not defined.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.

PEDOMAN KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI Error! Bookmark not defined.

BAB I Error! Bookmark not defined.

PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI Error! Bookmark not defined.

BAB II Error! Bookmark not defined.

ORGANISASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI Error! Bookmark not defined.

BAB III Error! Bookmark not defined.

KEGIATAN DAN TATA LAKSANA Error! Bookmark not defined.

BAB IV Error! Bookmark not defined.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN..... Error! Bookmark not defined.



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 823.3/I-PDM/DIR/IX/2025**

TENTANG

**PEDOMAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan, khususnya di rumah sakit, serta menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang paripurna, perlu dilakukan promosi kesehatan di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit, maka perlu diatur dengan peraturan direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Kerja Promosi Kesehatan Rumah Sakit;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/SK/Menkes/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
 11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG
PEDOMAN KERJA PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.
3. Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat PKRS adalah proses memberdayakan Pasien, keluarga Pasien, sumber daya manusia Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal.
4. Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit dengan nama jabatan kepala, direktur utama, atau direktur.
5. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
6. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SDM Rumah Sakit adalah semua tenaga yang bekerja di Rumah Sakit baik tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan.
7. Keluarga Pasien adalah setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
8. Pengunjung Rumah Sakit adalah setiap orang yang datang mengunjungi Rumah Sakit untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan yang lain.
9. Masyarakat Sekitar Rumah Sakit adalah sekumpulan orang yang tinggal dan/atau berinteraksi di area sekitar Rumah Sakit.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan PKRS bertujuan untuk memberikan acuan bagi Rumah Sakit dalam menyelenggarakan Promosi Kesehatan secara optimal, efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan bagi Pasien,



Keluarga Pasien, Pengunjung Rumah Sakit, SDM Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan PKRS.
- (2) PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip paradigma sehat, kesetaraan, kemandirian, keterpaduan, dan kesinambungan.
- (3) Penyelenggaraan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan manajemen PKRS; dan
 - b. pemenuhan standar PKRS.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan manajemen PKRS dan pemenuhan standar PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Kepala atau Direktur Rumah Sakit;
 - b. Tim PKRS RS Prima Husada Malang
 - c. Unit kerja fungsional yang dibentuk oleh profesional pemberi asuhan pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tim yang didasarkan pada kelas Rumah Sakit.
- (3) Profesional pemberi asuhan pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada Pasien.
- (4) Pelaksanaan manajemen PKRS dan pemenuhan standar PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur organisasi lainnya.

BAB III

MANAJEMEN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 5

Manajemen PKRS meliputi:

- a. pengkajian;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.



Pasal 6

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk melihat penyebab faktor risiko terjadinya penyakit berdasarkan perilaku dan non perilaku.
- (2) Pengkajian bagi Pasien dan Keluarga Pasien dapat dilakukan berdasarkan formulir pengkajian Pasien (*assessment patient*).
- (3) Pengkajian bagi Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit dapat dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang meliputi:
 - a. data demografi;
 - b. data penyakit;
 - c. data kunjungan; dan
 - d. data perilaku.
- (4) Pengkajian bagi SDM Rumah Sakit dilaksanakan dengan menggunakan instrumen identifikasi perilaku.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. penetapan tujuan dan sasaran;
 - b. penentuan materi;
 - c. penentuan metode berdasarkan tujuan dan sasaran;
 - d. penentuan media;
 - e. penyusunan rencana evaluasi; dan
 - f. penyusunan jadwal pelaksanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan instalasi, unit, atau tim lain secara berkesinambungan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala atau Direktorat Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan sesuai dengan standar PKRS.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid dan akurat, serta sumber daya yang optimal termasuk sumber daya manusia yang profesional.



Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan PKRS dan mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKRS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen PKRS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

STANDAR PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 11

Standar PKRS meliputi:

- a. Rumah Sakit memiliki regulasi Promosi Kesehatan;
- b. Rumah Sakit melaksanakan asesmen Promosi Kesehatan bagi Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit;
- c. Rumah Sakit melaksanakan intervensi Promosi Kesehatan; dan
- d. Rumah Sakit melaksanakan monitoring dan evaluasi Promosi Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit memiliki regulasi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk menjamin terselenggaranya manajemen PKRS yang optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
- (2) Regulasi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit;
 - b. organisasi PKRS beserta tugas, fungsi, wewenang ;
 - c. tenaga pengelola PKRS yang kompeten dan sesuai dengan jumlah kapasitas tempat tidur Rumah Sakit;
 - d. penyediaan anggaran serta sarana dan prasarana untuk terselenggaranya program PKRS; dan
 - e. pelaksanaan Promosi Kesehatan berkelanjutan.

Pasal 13

Pelaksanaan asesmen Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga Pasien;
- b. asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi SDM Rumah Sakit; dan



- c. asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.

Pasal 14

- (1) Intervensi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen Promosi Kesehatan.
- (2) Intervensi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intervensi Promosi Kesehatan berfokus pada pasien dan keluarga Pasien;
 - b. intervensi Promosi Kesehatan pada SDM Rumah Sakit; dan
 - c. intervensi Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 huruf d meliputi:

- a. monitoring dan evaluasi terhadap intervensi Promosi Kesehatan; dan
- b. peninjauan terhadap kebijakan, pedoman/panduan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan standar PKRS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Untuk terselenggaranya PKRS secara optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan, Rumah Sakit membentuk satu unit kerja fungsional yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan PKRS.
- (2) Unit kerja fungsional (Tim PKRS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan Tim PKRS.

Pasal 18

Tim PKRS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 memiliki tugas:

- a. melaksanakan perencanaan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan PKRS;



- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- d. menggerakkan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat masyarakat yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain terkait;
- e. menyusun pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasional (SPO), pelaksanaan, dan regulasi internal PKRS;
- f. membuat dan/atau mengembangkan media Promosi Kesehatan;
- g. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan Promosi Kesehatan yang terintegrasi;
- i. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara PKRS;
- j. melaksanakan pengembangan metode dan penelitian;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan profesional pemberi asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit; dan
- l. mendorong terwujudnya Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.

BAB VI

PENILAIAN PKRS

Pasal 19

- (1) Penilaian penyelenggaraan PKRS dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Penilaian internal PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap satu bulan sekali oleh Tim PKRS sebagai bagian kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKRS di unit, ruang dan Instalasi.
- (3) Penilaian eksternal PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan Manajemen Komunikasi dan Edukasi dalam STARKES Tahun 2022

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan seluruh kegiatan Tim PKRS dilakukan oleh Dewan Pakar PKRS
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKRS di unit, ruang, instalasi dilakukan oleh Tim PKRS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;



- b. bimbingan teknis; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan direktur ini

Pasal 22

- (2) Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 September 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

PEDOMAN KERJA TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab dan setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat rujukan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan promotif dan preventif di Rumah Sakit dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan PKRS. Untuk itu Rumah Sakit berperan penting dalam melakukan Promosi Kesehatan baik untuk Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, maupun Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.

Berdasarkan kebijakan nasional Promosi Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, Promosi Kesehatan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, penciptaan lingkungan yang kondusif, penguatan gerakan masyarakat, pengembangan kemampuan individu, dan penataan kembali arah pelayanan kesehatan. Promosi Kesehatan dilakukan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan serta didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid/akurat, serta sumber daya yang optimal, termasuk sumber daya manusia yang profesional.

Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan pada 5 (lima) tingkat pencegahan yang meliputi Promosi Kesehatan pada kelompok masyarakat yang sehat sehingga mampu meningkatkan kesehatan, Promosi Kesehatan tingkat preventif pada kelompok berisiko tinggi (*high risk*) untuk mencegah agar tidak jatuh sakit (*specific protection*), Promosi Kesehatan tingkat kuratif agar Pasien cepat sembuh atau tidak menjadi lebih parah (*early diagnosis and prompt treatment*), Promosi Kesehatan pada tingkat rehabilitatif untuk membatasi atau mengurangi kecacatan (*disability limitation*), dan Promosi Kesehatan pada Pasien baru sembuh (*recovery*) dan pemulihan akibat penyakit (*rehabilitation*).

Dengan terselenggaranya Promosi Kesehatan di Rumah Sakit dapat mewujudkan Rumah Sakit yang berkualitas yang memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit baik nasional maupun internasional. Integrasi Promosi Kesehatan dalam asuhan Pasien melalui peningkatan komunikasi dan edukasi yang efektif juga dapat mewujudkan peningkatan mutu dan keselamatan Pasien. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi Rumah Sakit, menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian sentinel disebabkan karena ketidakefektifan dalam berkomunikasi, baik antar Profesional

Pemberi Asuhan (PPA), maupun antara PPA dengan Pasien. Selain itu, penyelenggaraan PKRS yang baik dan berkesinambungan dapat menciptakan perubahan perilaku dan lingkungan berdasarkan kebutuhan Pasien.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menjamin pemenuhan hak setiap orang dalam memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan dan untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang paripurna di Rumah Sakit, diperlukan adanya PKRS melalui pelaksanaan manajemen PKRS dan pemenuhan standar PKRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Terciptanya masyarakat rumah sakit yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku pasien rumah sakit serta pemeliharaan lingkungan rumah sakit dan memanfaatkan dengan baik semua pelayanan yang disediakan rumah sakit.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Meningkatkan kualitas pelayanan medis dengan memberikan informasi medis yang selektif, terpercaya dan menyeluruh kepada setiap pasien dan keluarganya yang datang ke rumah sakit
2. Menyediakan informasi yang dibutuhkan pasien maupun keluarganya seperti rencana promotif, diagnosis kerja, rencana diagnostik, rencana terapi, prognosis, rencana rehabilitatif dan rencana preventif.
3. Menyempurnakan sistem kerja Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Prima Husada demi peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
Mensukseskan program pemerintah dalam bidang kesehatan dan promosi kesehatan khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan sistem kesehatan nasional.

1.3 Sasaran

Sasaran kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit di RS adalah masyarakat di rumah sakit yang terdiri dari :

1. Direktur Rumah Sakit
2. SDM Rumah Sakit
3. Pasien
4. Keluarga pasien
5. Masyarakat yang berkunjung ke RS.
6. Petugas RS Prima Husada Malang
7. Masyarakat yang berada di sekitar lingkungan RS Prima Husada Malang
8. Pemangku Kepentingan terkait

BAB II

TATALAKSANA PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

2.1 Prinsip Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

2.1.1 Paradigma Sehat

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lebih difokuskan pada peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan, sehingga tidak hanya terfokus pada pemulihan atau penyembuhan penyakit. Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat rujukan berperan penting mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya promotif dan preventif dalam mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit dan masyarakat, serta menjaga agar tetap dalam keadaan sehat. Penyelenggaraan PKRS mengedepankan upaya-upaya promotif dan preventif, dengan tidak mengesampingkan tindakan kuratif dan rehabilitatif, sehingga seluruh aspek pelayanan kesehatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan dapat menciptakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar.

Penyelenggaraan PKRS sangat membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, dalam rangka merubah perilaku Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk mencegah terjadinya penyakit berulang karena perilaku yang sama, mencegah dan mengurangi risiko terjadinya penyakit, serta menjaga agar tetap dalam keadaan sehat, dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu penyelenggaraan PKRS perlu didukung dengan regulasi, kebijakan, kelembagaan, tenaga, sumber dana, sarana dan prasarana yang memadai, sehingga penyelenggaraan Promosi Kesehatan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit, *patien safety*, dan terpenuhinya hak-hak Pasien, dan menciptakan Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat.

2.1.2 Kesetaraan

Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, mudah diakses, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sasaran. Penyelenggaraan PKRS harus dapat menjangkau seluruh sasaran dengan tidak membedakan baik akses dan mutu pelayanan. Promosi Kesehatan harus dapat memberi akses terhadap yang membutuhkan maupun masyarakat umum, sehingga tidak ada ketimpangan baik berdasarkan sasaran, status sosial, ekonomi, suku, agama, ras, jenis kelamin, dan lain sebagainya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

2.1.3 Kemandirian

Penyelenggaraan PKRS mendorong Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk berperilaku hidup

bersih dan sehat secara mandiri sehingga tidak mengalami sakit berulang karena perilaku yang sama serta mampu mencegah dan mengelola risiko terjadinya penyakit.

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dalam rangka memandirikan individu, Keluarga Pasien, dan masyarakat agar mampu menghadapi masalah-masalah kesehatan potensial (yang mengancam) yaitu dengan cara mencegahnya dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang sudah terjadi dengan cara menanganinya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, mampu berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya (*problem solving*), baik masalah-masalah kesehatan yang sudah diderita maupun yang potensial (mengancam), secara mandiri (dalam batas-batas tertentu). Dengan demikian dapat terwujudnya tujuan dari pembangunan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

2.1.4 Keterpaduan dan Kesiambungan

Penyelenggaraan PKRS dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan multi profesi/multi disiplin yang ada di unit/instalasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan unit terkait lainnya. Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan dalam rangka perubahan perilaku sasaran, yang berulang sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan kesehatan. Untuk itu dalam pelaksanaanya harus melibatkan multi profesi/disiplin, instalasi/unit fungsional, lintas program dan lintas sektor, dan kelompok masyarakat yang peduli kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan promosi kesehatan Rumah Sakit tidak terbatas pada Pasien dan Keluarga Pasien di Rumah Sakit, melainkan sampai pada saat pasien pulang dan berkumpul dengan komunitas di masyarakat. Untuk itu penyelenggaraan PKRS terpadu dan terintegrasi dengan upaya Promosi Kesehatan di puskesmas sehingga Promosi Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit dan puskesmas dapat bersinergi secara berkelanjutan.

2.2 Tatalaksana Promosi Kesehatan

Penyelenggaraan PKRS dilakukan dalam rangka memberdayakan Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk berubah dari tidak tahu menjadi tahu (aspek *knowledge*), dari tahu menjadi mau (aspek *attitude*), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek *practice*), agar dapat mencegah terjadinya penyakit dan meningkatkan kesehatan. Agar penyelenggaraan PKRS berjalan dengan baik, diperlukan adanya manajemen PKRS secara menyeluruh, yang meliputi:

2.2.1 Pengkajian/Assesmen

Pengkajian dilaksanakan oleh pelaksana PKRS di masing-masing instalasi/unit pelayanan Rumah Sakit setiap tahun, dengan pendekatan sasaran untuk melihat penyebab dan faktor risiko terjadinya penyakit berdasarkan perilaku dan non perilaku. Perilaku meliputi pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan tindakan (*practice*). Pengetahuan yang dikaji antara lain apa yang diketahui oleh sasaran tentang penyakit, cara menghindari dan mengendalikan penyakit, cara memelihara kesehatan, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Sikap yang dikaji adalah respon sasaran terhadap kesehatan. Tindakan yang dikaji adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh sasaran dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan. Non perilaku meliputi

ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, kebijakan kesehatan, pendidikan kesehatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kebijakan publik berwawasan kesehatan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Non perilaku yang dikaji adalah faktor yang terkait langsung dengan penyebab masalah kesehatan.

Pengkajian bagi Pasien dan Keluarga Pasien dapat dilakukan berdasarkan formulir pengkajian Pasien, dengan menganalisis formulir pengkajian Pasien (*assessment patient*), yang meliputi:

1. kemampuan baca (tidak bisa/Tidak Lancar/ Lancar).
2. Bahasa yang digunakan (Indonesia/Daerah / Asing)\
3. Tingkat Pendidikan (Tidak Sekolah/ SD/SMP/SMA/DIPLOMA/SARJANA/S2)
4. Hambatan Emosional & Motivasi (Depresi / Senang/ Marah)
5. Keterbatasan Fisik & Kognitif (Tuna Rungu / Tuna Wicara / Normal)
6. Kesiediaan Pasien Menerima Informasi (Bersedia/Tidak Bersedia)
7. Keyakinan/Kepercayaan/Nilai yang dianut (Ada..... / Tidak ada)

Dari seluruh penilaian tersebut dapat digunakan untuk menentukan kesimpulan apakah pasien mengalami hambatan atau tidak dalam menerima edukasi agar edukasi dapat efektif dilakukan.

Pengkajian bagi SDM Rumah Sakit dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap keadaan SDM Rumah Sakit dengan menggunakan instrumen asesmen SDM Rumah Sakit yang meliputi:

- 1) Karakteristik SDM Rumah Sakit, terdiri atas umur, jenis kelamin, tempat bekerja;
- 2) Status gizi, terdiri atas Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar perut, LLA;
- 3) Kondisi kesehatan, terdiri atas tekanan darah, frekuensi nadi, gula darah sewaktu, kolesterol total, dan asam urat;
- 4) Perilaku, terdiri atas status merokok, riwayat konsumsi alkohol, aktivitas fisik, makan sayur dan buah, riwayat vaksinasi, cek kesehatan berkala dan risiko terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja; dan
- 5) Riwayat penyakit yang pernah diderita dan keluarga.

Pengkajian terhadap Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit dilaksanakan menggunakan data sekunder yang terdiri atas data demografi, data penyakit, data kunjungan dan data perilaku. Data demografi diuraikan menurut, usia, etnis, agama, tingkat pendidikan, serta bahasa yang digunakan. Data penyakit yaitu data penyakit yang ditangani di Rumah Sakit dalam satu tahun dikelompokkan berdasarkan diagnosa penyakit. Data kunjungan yaitu dengan cara merinci kunjungan di setiap instalasi/unit dalam bulan 1 tahun terakhir. Data perilaku didapat dari hasil survei Rumah Sakit, atau survei kesehatan (Riskesdas)/survei kesehatan dari lembaga lainnya. Untuk mengetahui dampak terhadap keberadaan Rumah Sakit serta pola penyakit di wilayah setempat, pengkajian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data kondisi lingkungan sekitar Rumah Sakit dan kondisi wilayah setempat seperti daerah endemis rabies, malaria, DHF, dsb. Data dapat menggunakan laporan tahunan dari dinas kesehatan pemerintah daerah setempat, seperti data kejadian penyakit menular dan tidak menular, prevalensi stunting, gizi buruk, TBC, cakupan imunisasi lengkap, angka kematian ibu dan anak, dan sebagainya, serta data terhadap sumber-sumber yang ada di masyarakat yang dapat dijadikan mitra.

2.2.2 Perencanaan

Perencanaan PKRS dibuat oleh pengelola PKRS, setiap tahun disetiap instalasi/unit pelayanan dengan melibatkan multi profesi/disiplin, profesional pemberi asuhan (PPA), dan unsur lain yang terkait dengan Promosi Kesehatan bagi sasaran di Rumah Sakit. Perencanaan PKRS dibuat berdasarkan hasil kajian kebutuhan Promosi Kesehatan, dengan menetapkan target capaian, kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga, dana dan menentukan metode pelaksanaan perubahan perilaku, yang akan dijadikan sebagai bahan dalam monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah dalam perencanaan PKRS sebagai berikut:

A. Pedoman Pengisian

- 1) Penetapan tujuan perubahan perilaku sasaran, mencakup target peningkatan pengetahuan, peningkatan sikap, peningkatan perilaku, dan peningkatan status kesehatan.
- 2) Penentuan Kemampuan Belajar pasien apakah dapat merubah perilaku, dapat menguasai informasi
- 3) Penentuan Hambatan pasien maupun keluarga pasien dalam menerima edkasi (Tidak ada, Takut, Tidak Tertarik, Nyeri/ Tidak nyaman , Gangguan Kognitif, Hambatan Bahasa)
- 4) Intervensi terhadap hambatan jika tidaka da maka edukasi dapat dilanjutkna jika terdapat hambatan maka dapat ditentukan dengan membatasi materi , menggunakan penerjemah, mengulangi edukasi , mengedukasi keluarga jika pasien mengalami hambatan kognitif maupun psikologis.
- 5) Penentuan materi Promosi Kesehatan yang dibuat secara praktis mudah dipahami oleh sasaran. Penentuan metode berdasarkan tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya Rumah Sakit (tenaga, waktu, biaya, dan sebagainya).
- 6) Penentuan media / material yang akan digunakan untuk membantu penyampaian informasi dan edukasi dengan bahasa mudah dimengerti, meliputi media cetak, media audiovisual, media elektronik, media luar ruang, dan sebagainya. Media cetak dapat menggunakan Leaflet jika materi yang di edukasikan ada dalam Leaflet maka penulisan di Lembar DRM cukup menggunakan Kode leaflet yang tertera di bagian pojok kanan atas leaflet. Jika materi edukasi tidak ada materialnya maka harus dituliskan lengkap didalam dokumen rekam medis Form RM020 Edukasi Terintegrasi.
- 7) Perencanaan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan bersama dengan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien dan keadaan pasien maupun keluarga.
- 8) Penyusunan rencana evaluasi, meliputi waktu dan tempat pelaksanaan evaluasi, kelompok sasaran yang akan dievaluasi, pelaksana kegiatan evaluasi, dan sebagainya.
- 9) Hasil yang diharapkan maka pasien atau keluarga dapat menunjukkan tingkat pengetahuan yang diharapkan terhadap penyakit atau membutuhkan petunjuk tambahan .
- 10) Edukasi Tambahan atau lanjutan dapat dilakukan oleh seluruh PPA jika pasien masih melewati masa perawatan di rumah sakit dan dapat diberikan edukasi lanjutan pada terkait dengan masalah kesehatannya di fasilitas Kesehatan selanjutnya .

B. Poin Edukasi Yang disampaikan

Kebutuhan Edukasi	Keterangan Penjelasan
Hak,Kewajiban keluarga-tata tertib	Pasien diberikan mengenai 18 hak pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit dan 8 kewajiban pasien . Tata Tertib dirumah sakit terkait jam berkunjung, penunggu pasien, pembawaan harta benda dan prosedur lainnya

Status penjaminan dan cara bayar	Cara pembayaran perawatan pasien menggunakan pembayaran mandiri, BPJS atau Asuransi . Kelengkapan berkas dan syarat kondisi khusus yang harus di lengkapi di admisi , Serta perkiraan pembiayaan.
Identifikasi kebutuhan pasien	Identifikasi kebutuhan pasien terkait kebutuhan penerjemah / tidak, pendamping khusus atau kebutuhan perwakilan dalam pemberian informasi dan edukasi .
Diagnosis dan rencana asuhan	Diagnosis secara rinci pasien, Indikasi dirawat, Rencana Asuhan yang akan dilakukan di ruang rawat inap/ICU/Perinatologi/Maternitas , Asuhan yang diharapkan
Identifikasi pasien	Edukasi terkait pemberian gelang pasien yang berisikan Nama, Tgl Lahir, Usia dan No. RM serta pembeda gelang jenis kelamin.
Orientasi ruangan kebersihan lingkungan	Meliputi Ruangan rawat inap , letak lantai , akses pelayanan, Fasilitas (Kursi, Televisi, AC, Kamar Mandi dsb) beserta cara penggunaan dengan baik dan benar
Asuhan farmasi penggunaan obat yang aman	Penggunaan Prinsip 6 Benar dalam Pemberian obat yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute dan benar pendokumentasian
Interaksi obat obat obat & makanan	Potensi interaksi obat dengan obat obatan lain dan interaksi obat dengan makanan/ minuman yang harus di hindari.
Asuhan Gizi : Diet & Nutrisi	Penjelasan mengenai Diet sesuai kebutuhan pasien dan sesuai kondisi penyakit serta informasi mengenai 10 pedoman gizi seimbang
Batasan diet – penyimpanan-cegah kontaminasi	Edukasi mengenai cara penyimpanan makanan di ruang rawat inap untuk mencegah kontaminasi dari luar . Cara konsumsi dengan baik dan benar untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan . Peraturan dilarang memberikan/ membelikan makanan dari luar khusus pasien.
Pengelolaan nyeri	Edukasi mengenai pengertian Nyeri, Proses nyeri timbul, Cara pengelolaan nyeri dengan baik dan benar
Pencegahan Risiko jatuh	Edukasi terkait tanda resiko jatuh pasien di bed pasien dan tatacara pencegahannya.
Perawatan dan penggunaan alat medis yang aman	Edukasi terkait penggunaan alat medis yang digunakan kepada pasien, Pengenalan nama alat, Jenis dan fungsi alat untuk pemeriksaan maupun untuk membantu proses mempercepat pemulihan.
Rencana kepulangan	Edukasi terkait waktu rencana kepulangan, tatacara pengadministrasian pasien pulang, Edukasi Kontrol ulang dan Obat untuk pulang.
Teknik Rehabilitasi	Pengertian Teknik rehabilitasi, Indikasi rehabilitasi, Tata cara rehabilitasi medik dosis, cara Gerakan.

Hand hygiene	Pengertian Hand Hygiene, Cara Melakukan,waktu harus melakukan cuci tangan
Penggunaan APD	Tata cara penggunaan masker dengan baik dan benar , etika batuk dan bersin dengan benar.
Pencegahan penyakit	Edukasi mengenai tatacara pencegahan penyakit disesuaikan dengan diagnosis dan kondisi perjalanan penyakit pasien. Pencegahan terhadap penularan penyakit dari pasien lain, pasien ke keluarga atau dari pengunjung ke pasien dilakukan dengan penggunaan APD dengan baik dan benar, penerapan PHBS, Penerapan cara Batuk dan bersin yang efektif
Etika batuk-bersin	Etika Batuk Bersin menggunakan lengan baju bagian dala, Menggunakan tissue dan harus melakukan cuci tangan setelah bersin dan batuk
Protokol Kesehatan	1. Mencuci Tangan. 2. Memakai Masker. 3. Menjaga Jarak. 4. Menjauhi Kerumunan. 5. Mengurangi Mobilitas.
Pre-Op Anestesi	emberian informasi dari perawat ke pasien juga keluarga pasien meliputi berbagai informasi tentang tindakan operasi , persiapan sebelum operasi , prosedur anestesi dan Tindakan operasi.
Pre-Op penandaan	Edukasi Penandaan daerah operasi, Lokasi ,
EWS	Penjelasan penilaian Early Warning Score pada pasien dan keluarga, tingkat kewaspadaan dan
As.menjelang akhir kehidupan pasien	Edukasi AS Menjelang akhir kehidupan pasien
Setiap kali melakukan tindakan	Edukasi tatacara Tindakan, Efek samping dan distraksi jika Tindakan menyebabkan rasa nyeri
Rujukan Edukasi berkelanjutan kekomunitas/FKTP	Edukasi terkait kebutuhan rujukan edukasi lebih lanjut sesuai ke fasilitas Kesehatan tingkat pertama, atau ke komunitas yang ada disekitar RSPHM
Rujuk balik ke FKTP	Edukasi terkait pengembalian pasien yang telah stabil dapat dilakukan di Fasilitas Tingkat Pertama dan edukasi lebih lanjut prosedur dan tatacara Pasien Rujuk Balik khusus BPJS.
Asuhan lanjutan dirumah	Asuhan mengenai tatacara peningkatan Kesehatan dirumah setelah selesai perawatan di rumah sakit disesuaikan dengan kebutuhan dan penyakit pasien .
Hasil Asuhan	Penjelasan hasil asuhan yang telah diberikan

2.2.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan PKRS dilakukan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan, dengan berbagai metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid/akurat, serta sumber daya yang optimal termasuk sumber daya manusia yang profesional. Pelaksanaan PKRS menjadi tanggung jawab instalasi/unit/tim PKRS serta melibatkan multi disiplin/multi profesi terkait sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan PKRS dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan edukasi Kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh kegiatan edukasi kepada pasien dilakukan oleh PPA dan di dokumentasikan dalam rekam medis RM019 – Rev dan di tuliskan dalam lembar Edukasi terintegrasi RM020.

1) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat, yang merupakan upaya membantu atau memfasilitasi sasaran, sehingga memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk mencegah dan atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya. Berbagai metode pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan di Rumah Sakit pada sasaran, antara lain berbentuk pelayanan konseling terhadap:

- a. Pasien dan keluarga pasien di rawat inap maupun rawat jalan dapat dilakukan beberapa kegiatan pemberdayaan Pasien seperti konseling di tempat tidur (disebut juga *bedside health promotion*), diskusi kelompok (untuk penderita yang dapat meninggalkan tempat tidur) terhadap upaya peningkatan kesehatan terhadap penyakit yang diderita, *biblioterapi* (menyediakan atau membacakan bahan-bahan bacaan bagi Pasien). Konseling penggunaan obat, alat bantu, dan sebagainya. Pemberdayaan Keluarga Pasien misalnya konseling terhadap diagnosa penyakit yang diderita Pasien, diskusi kelompok dengan mengumpulkan Keluarga Pasien dalam upaya meningkatkan hidup sehat. Pelaksanaan pemberdayaan Pasien dan Keluarga Pasien dalam konseling/edukasi dicatat dalam rekam medis dan dilaksanakan oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Dalam melaksanakan pemberdayaan Pasien dan Keluarga Pasien agar intervensi Promosi Kesehatan berjalan efektif harus memperhatikan sosial budaya, tingkat pendidikan, ekonomi, etnis, agama, bahasa yang digunakan serta hambatan komunikasi, emosional dan motivasi untuk berubah, keterbatasan fisik dan kognitif, serta kesediaan Pasien menerima informasi. Pemberdayaan pasien dan keluarga pasien dalam Promosi Kesehatan berkelanjutan dilaksanakan pada Pasien setelah pulang dari Rumah Sakit atau rujuk balik sesuai dengan hasil *re-asesmen* kebutuhan Promosi Kesehatan. Bentuk kegiatan dapat berupa kunjungan rumah untuk melakukan konseling/edukasi kepada Pasien dan Keluarga Pasien dalam rangka upaya mengendalikan faktor risiko penyakit dan peningkatan kesehatan, pembinaan komunitas dimana Pasien sebagai bagian dari kelompok masyarakat peduli kesehatan seperti kelompok peduli TBC, HIV/AIDS, komunitas geriatic, Kelompok DOLINA dan sebagainya. Pembinaan teknis medis dilakukan oleh profesional sesuai dengan keahlian.
- b. SDM Rumah Sakit, dalam rangka merubah perilaku berdasarkan hasil asesmen, dilakukan intervensi perubahan perilaku, sesuai dengan kebutuhan Promosi Kesehatan, seperti intervensi terhadap masih banyaknya SDM Rumah Sakit yang merokok, maka kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan konseling merokok/*coaching* berhenti merokok. Membudayakan aktivitas fisik setiap SDM Rumah Sakit dengan melakukan senam secara rutin setiap hari tertentu dan dilakukan pengukuran kebugaran, edukasi terhadap risiko pekerjaan dan lingkungan terutama sampah medis, pentingnya pengendalian IMT normal, di setiap unit/instalasi sebagai *agent of change* (AoC) sebagai motor dalam perubahan perilaku, memberikan hadiah” (*reward*) atau harus

“dipaksa” menggunakan peraturan dan sanksi (*punishment*), serta peningkatan keterampilan SDM Rumah Sakit dengan pelatihan, sosialisasi dan sebagainya.

- c. Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit, pelaksanaan Promosi Kesehatan dilakukan dalam rangka perubahan perilaku yang berisiko dengan peningkatan pengetahuan, menumbuhkan sikap dan kemauan individu dan masyarakat sehingga dapat berperilaku hidup bersih dan sehat dan lingkungan sehat. Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui penyuluhan terhadap penyakit yang berisiko tinggi dan berbiaya mahal, dan terbanyak yang terjadi di Rumah Sakit, penyebarluasan informasi melalui media komunikasi, media cetak (leaflet, poster, dan baliho), media massa penyedia informasi (koran, TV, radio, buletin, penayangan video pada TV di tempat-tempat yang strategi, dan sebagainya), penyuluhan massa, demonstrasi/kampanye kesehatan, pemeriksaan kesehatan, pembinaan pembentukan kelompok peduli kesehatan, pengembangan daerah binaan Rumah Sakit, dan penggerakan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit dan lain sebagainya.

2). Advokasi

Advokasi dibutuhkan apabila dalam upaya memberdayakan sasaran PKRS membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain, seperti dalam rangka pelaksanaan Promosi Kesehatan yang terintegrasi perlu dibuat kebijakan oleh direktur Rumah Sakit tentang pelaksanaan Promosi Kesehatan terhadap hasil asesmen Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit. Selain itu diperlukan juga dukungan kebijakan antara lain kelembagaan, organisasi, tenaga, sarana dan prasarana. Contoh lainnya yaitu untuk mengupayakan adanya kebijakan lingkungan Rumah Sakit yang tanpa asap rokok, pengaturan tentang sampah baik sampah medis dan sampah non medis, serta kebijakan terhadap hasil asesmen yang ditemukan pada sasaran dan lain sebagainya, perlu melakukan advokasi kepada wakil-wakil rakyat dan pimpinan daerah atau pemangku kepentingan lainnya untuk diterbitkannya peraturan/kebijakan yang berkomitmen dalam pelaksanaan PKRS seperti tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mencakup di Rumah Sakit, kebijakan mengharuskan seluruh SDM Rumah Sakit menerapkan PHBS, kebijakan pelaksanaan PKRS harus dilaksanakan pada setiap unit/intalasi yang terintegrasi dan didukung oleh tenaga profesional, dana sarana dan prasarana, dan lain sebagainya

a. Kebijakan

Dukungan kebijakan dalam advokasi diperlukan antara lain kelembagaan, organisasi, tenaga, sarana dan prasarana.

Contoh:

- 1) Kebijakan lingkungan Rumah Sakit tanpa asap rokok (KTR),
- 2) Kebijakan tentang sampah baik sampah medis dan sampah non medis,
- 3) Kebijakan terhadap hasil pengkajian yang ditemukan pada sasaran dan lain sebagainya, perlu melakukan advokasi kepada wakil-wakil rakyat dan pimpinan daerah, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya
- 4) Kebijakan mengharuskan seluruh SDM Rumah Sakit menerapkan PHBS, kebijakan pelaksanaan PKRS harus dilaksanakan pada setiap unit/intalasi yang terintegrasi dan didukung oleh tenaga profesional, dana sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

- b. Metode dalam advokasi
- c. Metode advokasi antara lain: lobby, seminar, sosialisasi, dan workshop.
- d. Data: dukungan: data demografi dan informasi keadaan situasi Rumah Sakit.
- e. Tahapan-tahapan yang dapat memandu advokasi di Rumah Sakit sebagai berikut:
 - 1) Memahami/menyadari persoalan yang diajukan
 - 2) Tertarik untuk ikut berperan dalam persoalan yang diajukan
 - 3) Mempertimbangkan sejumlah pilihan kemungkinan dalam berperan
 - 4) Menyepakati satu pilihan kemungkinan dalam berperan
 - 5) Menyampaikan langkah tindak lanjut

Jika kelima tahapan tersebut dapat dicapai selama waktu yang disediakan untuk advokasi, maka dapat dikatakan advokasi tersebut berhasil. Langkah tindak lanjut yang tercetus di ujung perbincangan (misalnya dengan membuat disposisi pada usulan/proposal yang diajukan) menunjukkan adanya komitmen untuk memberikan dukungan.
- f. Bahan Advokasi
 - Kata-kata kunci dalam penyiapan bahan advokasi adalah “Tepat, Lengkap, Akurat, dan Menarik”. Artinya bahan advokasi harus dibuat:
 - 1) Sesuai dengan sasaran (latar belakang pendidikannya, jabatannya, budayanya, kesukaannya, dan lain-lain).
 - 2) Sesuai dengan lama waktu yang disediakan untuk advokasi
 - 3) Mencakup unsur-unsur pokok, yaitu Apa, Mengapa, Dimana, Bilamana, Siapa Melakukan, dan Bagaimana melakukannya (5W + 1H).
 - 4) Memuat masalah dan pilihan-pilihan kemungkinan untuk memecahkan masalah.
 - 5) Memuat peran yang diharapkan dari sasaran advokasi.
 - 6) Memuat data pendukung, bila mungkin juga bagan, gambar, dan lain-lain.

3). Kemitraan

Baik dalam pemberdayaan masyarakat maupun advokasi, prinsip-prinsip kemitraan harus ditegakkan. Kemitraan dilaksanakan atas dasar bahwa pelaksanaan Promosi Kesehatan yang baik tidak dapat dilaksanakan oleh Rumah Sakit itu sendiri, melainkan melibatkan banyak unsur dan sektor terkait, sehingga tujuan Promosi Kesehatan dapat merubah perilaku dapat tercapai. Kemitraan dikembangkan berdasarkan kebutuhan Promosi Kesehatan. Pengelola PKRS harus bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, multi profesi, multi disiplin, dan seluruh instalasi/unit pelayanan fungsional, serta dinas kesehatan pemerintah daerah/lintas sektor terakit, Puskesmas/fasilitas kesehatan tingkat pertama/ jejaring pelayanan kesehatan, dan sumber-sumber yang ada di masyarakat seperti misalnya kelompok profesi, kelompok peduli kesehatan, pemuka agama, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan lain-lain.

A. Prinsip Kemitraan

Dalam melaksanakan kemitraan ada 3 (tiga) prinsip dasar kemitraan yang harus diperhatikan yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

- 1) Kesetaraan
 - Kesetaraan menghendaki tidak diciptakannya hubungan yang bersifat hirarkhis (atas-bawah). Semua harus diawali dengan kesediaan menerima bahwa masing-masing berada dalam kedudukan yang sederajat. Keadaan

ini dapat dicapai bila semua pihak bersedia mengembangkan hubungan kekeluargaan, yaitu yang dilandasi kebersamaan atau kepentingan bersama.

2) Keterbukaan

Dalam setiap langkah menjalin kerjasama, diperlukan adanya kejujuran dari masing-masing pihak. Setiap usul/saran/komentar harus disertai dengan itikad yang jujur, sesuai fakta, tidak menutup-nutupi sesuatu.

3) Saling menguntungkan

Solusi yang diajukan hendaknya selalu mengandung keuntungan di semua pihak (*win-win solution*). Misalnya dalam hubungan antara petugas Rumah Sakit dengan Pasien, maka setiap solusi yang ditawarkan hendaknya juga berisi penjelasan tentang keuntungannya bagi Pasien. Demikian juga dalam hubungan antara Rumah Sakit dengan pihak donatur.

B. Landasan Kemitraan

Terdapat tujuh landasan (dikenal dengan sebutan: tujuh saling) yang harus diperhatikan dan dipraktikkan dalam mengembangkan kemitraan, yaitu:

- 1) Saling memahami kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing.
- 2) Saling mengakui kapasitas dan kemampuan masing-masing.
- 3) Saling berupaya untuk membangun hubungan.
- 4) Saling berupaya untuk mendekati.
- 5) Saling terbuka terhadap kritik/saran, serta mau membantu dan dibantu.
- 6) Saling mendukung upaya masing-masing.
- 7) Saling menghargai upaya masing-masing.

C. Metode dan Media Kemitraan

Dalam pelaksanaannya, 3 (tiga) strategi tersebut diatas harus diperkuat dengan metode dan media yang tepat, serta tersedianya sumber daya yang memadai. Metode yang dimaksud adalah metode komunikasi, karena baik pemberdayaan, advokasi, maupun kemitraan pada prinsipnya adalah proses komunikasi. Oleh sebab itu perlu ditentukan metode yang tepat dalam proses tersebut. Pemilihan metode harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kemasan informasinya, keadaan penerima informasi (termasuk sosial budayanya), dan hal-hal lain seperti ruang dan waktu. Media atau sarana informasi juga perlu dipilih dengan cermat mengikuti metode yang telah ditetapkan. Selain itu juga harus memperhatikan sasaran atau penerima informasi. Bila penerima informasi tidak bisa membaca misalnya, maka komunikasi tidak akan efektif jika digunakan media yang penuh tulisan. Atau bila penerima informasi hanya memiliki waktu yang sangat singkat, maka tidak akan efektif jika dipasang poster yang berisi kalimat terlalu panjang.

D. Sumber Daya

Sumber daya utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan PKRS adalah sumber daya manusia yang profesional, mempunyai kompetensi Promosi Kesehatan dengan telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dipersyaratkan, sarana/peralatan termasuk media komunikasi, dan dana atau anggaran. Sumber daya manusia yang utama untuk PKRS meliputi:

- 1) Semua petugas Rumah Sakit yang melayani Pasien (PPA, tenaga kesehatan lainnya).

- 2) Tenaga khusus Promosi Kesehatan (yaitu para pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat).

2.2.4 Pelaksanaan Intervensi PKRS

Berdasarkan uraian mengenai strategi pelaksanaan PKRS yang didukung dengan metode dan media yang tepat serta sumber daya yang memadai tersebut di atas, berikut beberapa contoh pelaksanaan PKRS sesuai dengan strategi pelaksanaan PKRS:

1. Pelaksanaan Promosi Kesehatan pada pasien rawat jalan, karena keterbatasan waktu pelayanan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah Pasien, edukasi tambahan dapat dilakukan dengan cara profesional dalam bidangnya melatih tenaga kesehatan untuk menjadi edukator, kemudian dengan jalan mengumpulkan Pasien, Keluarga Pasien, pengantar Pasien dalam suatu ruangan dan dilakukan edukasi, dan diskusi kelompok, terhadap diagnosa dan cara mengendalikan faktor risiko. Penggunaan alat peraga seperti panthom, lembar balik, leaflet, poster dan penayangan video edukasi lainnya sangat membantu proses edukasi, untuk itu media yang tepat dan rinci sangat dibutuhkan. Yang perlu diperhatikan edukasi dilakukan berdasarkan kelompok diagnosa penyakit, pelaksanaan edukasi harus memperhatikan demografi, status sosial, kemampuan baca tulis, dan kesediaan menerima informasi.
2. Bagi pengunjung Pasien rawat inap, situasi kondisi rawat inap dapat berpengaruh pada psikologis pengunjung akan kondisi kesehatannya. Pembagian selebaran leaflet, poster, video informasi dan sebagainya yang dapat memberikan informasi tentang penyakit, dan cara mencegah dan menghindari dan mengendalikan sesuai dengan penyakit Pasien yang akan mereka jenguk dapat dilakukan. Selain itu, beberapa Rumah Sakit melaksanakan penyuluhan kelompok kepada para pembesuk ini, yaitu dengan mengumpulkan mereka yang menjenguk Pasien yang sama penyakitnya dalam satu ruangan untuk mendapat penjelasan dan berdiskusi dengan dokter ahli, atau tenaga kesehatan yang sudah terlatih yang menangani penderita. Misalnya, tiga puluh menit sebelum jam besuk para penjenguk Pasien penyakit dalam diminta untuk berkumpul dalam satu ruangan. Kemudian datang dokter ahli penyakit dalam dan tenaga kesehatan yang terlatih yang mengajak para penjenguk ini berdiskusi tentang penyakit-penyakit yang diderita oleh Pasien yang akan dijenguknya. Pada akhir diskusi, dokter ahli penyakit dalam atau tenaga kesehatan yang terlatih tadi berpesan agar hal-hal yang telah di diskusikan disampaikan juga kepada Pasien yang akan dijenguk.
3. Promosi Kesehatan pada ruang pendaftaran. Begitu Pasien masuk ke gedung Rumah Sakit, maka yang pertama kali harus dikunjunginya adalah ruang/tempat pendaftaran, di mana terdapat loket untuk mendaftar. Mereka akan tinggal beberapa saat di ruang pendaftaran itu sampai petugas selesai mendaftar. Setelah pendaftaran selesai barulah mereka satu demi satu diarahkan ke tempat yang sesuai dengan pertolongan yang diharapkan. Kontak awal dengan Rumah Sakit ini perlu disambut dengan Promosi Kesehatan. Sambutan itu berupa salam hangat yang dapat membuat mereka merasa tenteram berada di Rumah Sakit. Di ruang ini pula, disediakan informasi tentang Rumah Sakit tersebut yang dapat meliputi manajemen Rumah Sakit, dokter atau perawat jaga, pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit, serta informasi tentang penyakit baik pencegahan maupun tentang cara mendapatkan penanganan penyakit tersebut. Media informasi yang digunakan di ruang ini sebaiknya berupa poster dalam bentuk *neon box* yang memuat foto dokter dan perawat yang ramah disertai kata-kata "Selamat Datang, Kami Siap Untuk Menolong Anda" atau yang sejenis. Media yang lain yang dapat disiapkan di ruang ini misalnya *leaflet*, *factsheet*, dan TV.
4. Edukasi dilakukan kepada seluruh Pasien, yaitu di mana setiap petugas Rumah Sakit yang melayani Pasien meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan Pasien berkenaan dengan penyakitnya atau obat, atau perilaku yang harus dilakukannya. Selain itu juga disediakan satu ruang khusus bagi para Pasien rawat jalan yang memerlukan konsultasi atau ingin mendapatkan informasi. Ruang konsultasi ini disediakan di poliklinik dan dilayani oleh PPA sesuai dengan poliklinik yang bersangkutan. Tugas melayani dalam ruang konsultasi ini dapat digilir diantara PPA yang ada, yaitu mereka yang tidak bertugas di poliklinik, diberi tugas di ruang konsultasi. Konsultasi seyogyanya dilakukan secara individual. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan dilakukannya konsultasi secara berkelompok (5-6 Pasien sekaligus), jika keadaan memungkinkan. Jika demikian, maka ruang konsultasi ini sebaiknya cukup luas untuk menampung 6-7 orang. Ruang konsultasi sebaiknya dilengkapi dengan berbagai media komunikasi atau alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan. Media komunikasi yang efektif digunakan di sini misalnya adalah lembar balik (*flash cards*), gambar-gambar atau model-model anatomi, dan tayangan menggunakan OHP atau laptop dan LCD. Seorang Pasien yang hendak dioperasi katarak, mungkin menginginkan penjelasan tentang proses operasi katarak tersebut. Jika demikian, maka selain penjelasan lisan, tentu akan lebih memuaskan jika dapat disajikan gambar-gambar tentang proses operasi tersebut. Bahkan lebih bagus lagi jika dapat ditayangkan rekaman tentang proses operasi katarak melalui laptop dan LCD yang diproyeksikan ke layar.

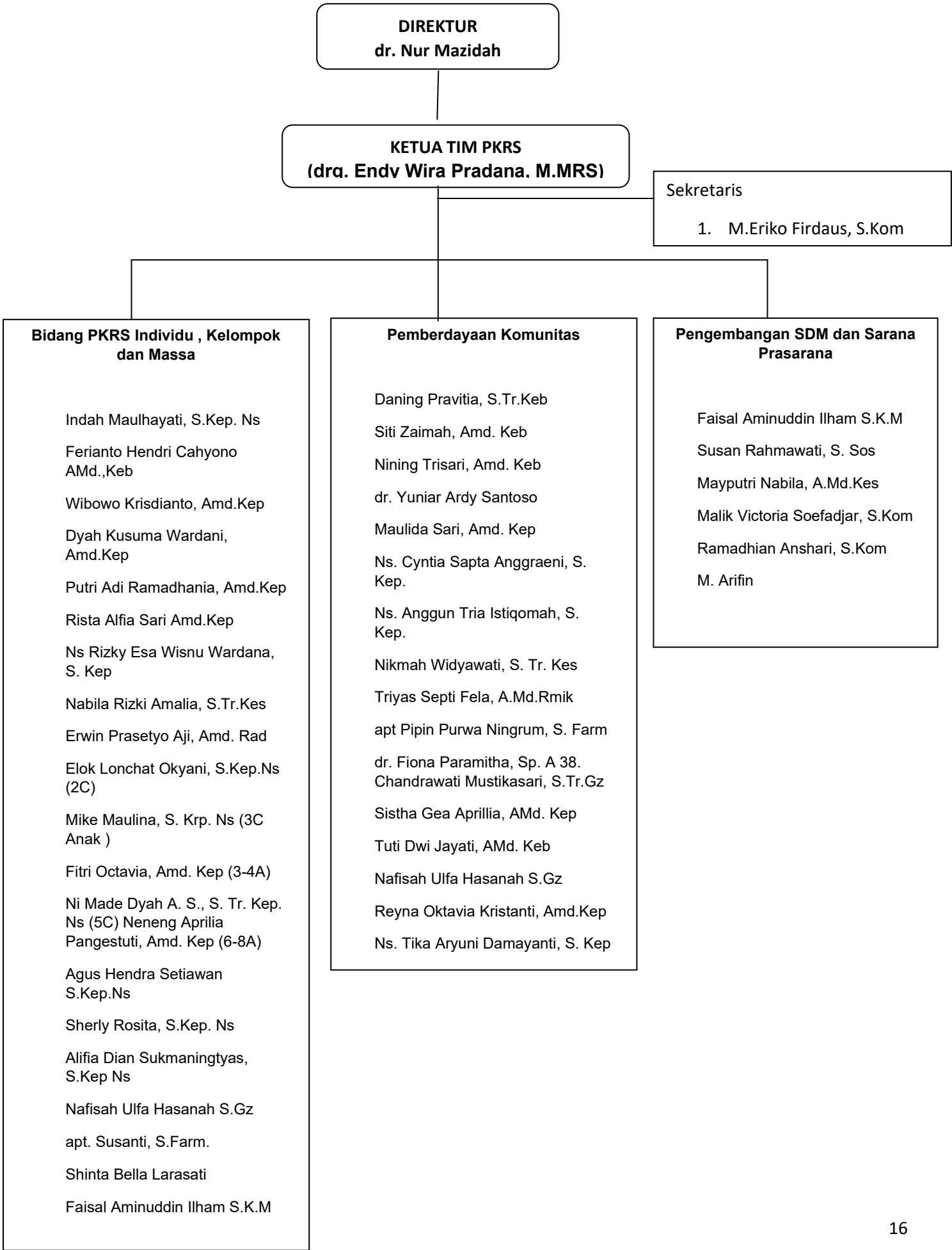
5. Bagi pengunjung/pengantar ke Rumah Sakit. Mereka ini tidak dalam keadaan sakit, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai media komunikasi yang tersedia di poliklinik. Oleh karena itu di setiap poliklinik, khususnya di ruang tunggu, perlu dipasang poster-poster, disediakan selebaran (*leaflet*), atau dipasang televisi dan VCD/DVD *player* yang dirancang untuk secara terus menerus menayangkan informasi tentang penyakit sesuai dengan poliklinik yang bersangkutan. Dengan mendapatkan informasi yang benar mengenai penyakit yang diderita Pasien yang diantaranya, si pengantar diharapkan dapat membantu Rumah Sakit memberikan juga penyuluhan kepada Pasien. Bahkan jika Pasien yang bersangkutan juga dapat ikut memperhatikan leaflet, poster atau tayangan yang disajikan, maka seolah-olah ia berada dalam suatu lingkungan yang mendorongnya untuk berperilaku sesuai yang dikehendaki agar penyakit atau masalah kesehatan yang dideritanya dapat segera diatasi.
6. Promosi Kesehatan di tempat pembayaran. Sebelum pulang, Pasien rawat inap yang sudah sembuh atau kerabatnya harus singgah dulu di tempat pembayaran. Di ruang perpisahan ini Pasien/kerabatnya itu memang tidak berada terlalu lama. Namun hendaknya Promosi Kesehatan juga masih hadir, yaitu untuk menyampaikan salam hangat dan ucapan selamat jalan, semoga semakin bertambah sehat. Perlu juga disampaikan bahwa kapan pun kelak Pasien membutuhkan lagi pertolongan, jangan ragu-ragu untuk datang lagi ke Rumah Sakit. Datang diterima dengan salam hangat dan pulang pun diantar dengan salam hangat. Biarlah kenangan yang baik selalu tertanam dalam ingatan Pasien/kerabatnya, sehingga mereka benar-benar menganggap Rumah Sakit sebagai penolong yang baik.
7. PKRS di pelayanan laboratorium. Selain dapat dijumpai Pasien (orang sakit), klien (orang sehat), dan para pengantarnya, kesadaran yang ingin diciptakan dalam diri mereka adalah pentingnya melakukan pemeriksaan laboratorium. Bagi Pasien adalah untuk ketepatan diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Bagi Keluarga Pasien atau mereka yang sehat lainnya adalah untuk memantau kondisi kesehatan, agar dapat diupayakan untuk tetap sehat. Pada umumnya Pasien, klien atau pengantarnya tidak tinggal terlalu lama di pelayanan laboratorium, oleh karena itu di kawasan ini sebaiknya dilakukan Promosi Kesehatan dengan media swalayan (*self service*) seperti poster-poster yang ditempel di dinding atau penyediaan *leaflet* yang dapat diambil gratis.
8. PKRS di pelayanan rontgen. Sebagaimana di pelayanan laboratorium, di pelayanan rontgen pun umumnya Pasien, klien, dan para pengantarnya tidak tinggal terlalu

lama. Di sini kesadaran yang ingin diciptakan dalam diri mereka pun serupa dengan di pelayanan laboratorium, yaitu pentingnya melakukan pemeriksaan rontgen. Bagi Pasien adalah untuk ketepatan diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Bagi Keluarga Pasien atau mereka yang sehat lainnya adalah untuk memantau kondisi kesehatan, agar dapat diupayakan untuk tetap sehat. Dengan demikian, Promosi Kesehatan yang dilaksanakan di sini sebaiknya juga dengan memanfaatkan media swalayan seperti poster dan leaflet.

9. PKRS di pelayanan obat/apotik juga dapat dijumpai baik Pasien, klien, maupun pengantarnya. Sedangkan kesadaran yang ingin diciptakan dalam diri mereka adalah terutama tentang manfaat obat generik dan keuntungan jika menggunakan obat generik. Kedisiplinan dan kesabaran dalam menggunakan obat, sesuai dengan petunjuk dokter. Pentingnya memelihara Taman Obat Keluarga (TOGA) dalam rangka memenuhi kebutuhan akan obat-obatan sederhana. Di pelayanan obat/apotik boleh jadi Pasien, klien, atau pengantarnya tinggal agak lama, karena menanti disiapkannya obat. Dengan demikian, selain poster dan leaflet, di kawasan ini juga dapat dioperasikan VCD/DVD Player dan televisinya yang menayangkan pesan-pesan tersebut di atas.
10. PKRS di pelayanan pemulasaraan jenazah tentu tidak akan dijumpai Pasien, karena yang ada adalah Pasien yang sudah meninggal dunia. Yang akan dijumpai di kawasan ini adalah para Keluarga Pasien atau teman-teman Pasien (jenazah) yang mengurus pengambilan jenazah dan transportasinya. Adapun kesadaran dan perilaku yang hendak ditanamkan kepada mereka adalah tentang pentingnya memantau dan menjaga kesehatan dengan mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Namun perlu diingat bahwa di kawasan ini suasananya adalah suasana berkabung, sehingga tidak mungkin dilakukan Promosi Kesehatan yang formal dan ketat. Dengan demikian, cara yang paling tepat adalah dengan memasang poster-poster dan atau menyediakan leaflet untuk diambil secara gratis. Akan lebih menyentuh jika pesan-pesan dalam poster dan leaflet juga dikaitkan dengan pesan-pesan keagamaan

BAB III
ORGANISASI TIM

3.1 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Tim PKRS

3.2 Sarana dan Fasilitas

Standar sarana/peralatan promosi kesehatan Rumah Sakit sesuai PMK Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit, meliputi:

1. Ruangan Pengelola
2. Ruangan Edukasi atau penyuluhan
3. LCD Proyektor
4. Layar Proyektor
5. Computer dan laptop
6. Portable Sound System
7. Public Address System (PSA)/Megaphone
8. Plypchart Besar/Kecil
9. Cassette recorder/player
10. Kamera foto
11. Food Model
12. Fantom Anatomi 1 Set
13. Fantom Gigi 1 set
14. Biblioterapi 1 set
15. Papan Informasi
16. Fantom mata 1 set
17. Fantom panggung 1 set
18. Alat Permainan Edukasi
19. Megaphone 1 set

3.3 Organisasi

3.3.1 Bidang PKRS Individu, Kelompok dan Massa

1. Ketua Pokja PKRS Individu, Kelompok dan Massa
 - a. Nama Jabatan : Ketua Pokja PKRS Individu, kelompok dan massa
 - b. Persyaratan Jabatan minimal:
 - 1) Sarjana (S1) diutamakan dokter minimal D3 Keperawatan
 - 2) Berpengalaman di bidang Promosi/penyuluhan minimal selama 1 tahun.
 - 3) Mempunyai sertifikat pelatihan komunikasi efektif
 - 4) Mempunyai Sertifikat Diklat PKRS tingkat terampil atau manajemen PKRS
 - c. Uraian tugas Ketua Bidang PKRS Individu, Kelompok dan massa
 - 1) Mengkoordinir pembuatan usulan kebutuhan kegiatan peningkatan SDM untuk promosi, pendidikan, Komunikasi, informasi dan edukasi pada pasien, keluarga, pengunjung dan karyawan di masing-masing ruangan, klinik, unit atau instalasi.
 - 2) Mengkoordinir pembuatan skedule atau jadwal promosi, pendidikan, komunikasi, informasi dan edukasi pada pasien, keluarga, pengunjung di ruang tunggu atau ruang edukasi atau melalui audio dan audio visual termasuk karyawan
 - 3) Membuat jadwal monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi, pendidikan, komunikasi, edukasi, informasi pada pasien, keluarga, pengunjung dan karyawan di ruangan, unit atau instalasi.
 - 4) Melakukan koordinasi antar SMF/instalasi/unit terkait terutama asuhan dari 4 profesi (medis, perawat, farmasi dan Gizi) dalam kegiatan terkait komunikasi-edukasi dan informasi di seluruh ruangan, unit atau instalasi.
 - 5) Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi regulasi PKRS, Standar Prosedur Operasional dan upaya pelaksanaannya di masing-masing kelompok profesional.
 - 6) Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi semua program Promosi Kesehatan Rumah Sakit kepada masing-masing pelaksana atau PPA di seluruh ruangan, unit atau instalasi
 - 7) Melakukan monitoring dan evaluasi program PKRS yang dilakukan oleh seluruh

ruangan, unit atau instalasi sesuai profesi.

- 8) Mendokumentasikan semua kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 9) Melaporkan kegiatan promosi, pendidikan, edukasi, informasi kesehatan pada pasien, keluarga, pengunjung, komunikasi antar karyawan Rumah Sakit dari seluruh ruangan, unit atau instalasi kepada ketua Tim PKRS

2. Anggota Bidang PKRS Individu, Kelompok dan massa

- a. Nama Jabatan : Anggota Pokja PKRS Individu, kelompok dan massa
- b. Persyaratan Jabatan minimal:
 - 1) Sarjana (S1) kesehatan minimal D3 kesehatan
 - 2) Berpengalaman di bidang Promosi Kesehatan RS minimal selama 3 bln.
 - 3) Mempunyai sertifikat pelatihan komunikasi efektif
 - 4) Mempunyai Sertifikat Diklat manajemen PKRS atau PKRS tingkat terampil
- c. Uraian tugas Anggota Pokja PKRS Individu, Kelompok dan massa
 - 1) Membuat usulan kebutuhan kegiatan PKRS termasuk peningkatan SDM/edukator
 - 2) Membuat rencana dan jadwal promosi, pendidikan, edukasi, informasi pada pasien, keluarga, pengunjung di ruang tunggu pendaftaran, klinik, Instalasi, ruang,
 - 3) Membuat usulan skedule monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengukuran mutu promosi, pendidikan, komunikasi, edukasi, informasi pada pasien, keluarga, pengunjung dan komunikasi antar karyawan di ruangan, unit atau instalasi.
 - 4) Melakukan koordinasi antar SMF/instalasi/unit terkait terutama asuhan dari PPA (medis, perawat, farmasi dan Gizi) dalam kegiatan terkait komunikasi-edukasi dan informasi di seluruh ruangan, unit atau instalasi.
 - 5) Sosialisasi regulasi, Pedoman kerja, program kerja Standar Prosedur Operasional, kebijakan dan upaya pelaksanaan PKRS di seluruh ruangan, unit atau instalasi
 - 6) Monitoring evaluasi semua kegiatan PKRS unit
 - 7) Melaporkan semua kegiatan PKRS di unit kepada ketua pokja PKRS individu, kelompok dan massa.

3.2.2 Bidang Pemberdayaan Komunitas Berbasis Rumah Sakit

1. Ketua Bidang Pemberdayaan Komunitas Berbasis Rumah Sakit

- a. Nama Jabatan : Ketua Pokja Pemberdayaan Komunitas Berbasis RSPH
- b. Persyaratan Jabatan minimal :
 - 1) S1 Kesehatan minimal D3 Kesehatan
 - 2) Berpengalaman di bidang PKRS minimal selama 1 tahun.
 - 3) Mempunyai sertifikat pelatihan komunikasi efektif
 - 4) Mempunyai Sertifikat Diklat manajemen PKRS atau PKRS tingkat terampil atau ikut dalam organisasi PPPKMI (Perkumpulan Pendidik dan Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia).
- c. Uraian Tugas Ketua
 - 1) Mengkoordinir pembuatan rencana program kegiatan promosi, pendidikan, edukasi, informasi untuk pemberdayaan komunitas berbasis Rumah Sakit, di masing-masing kelompok baik langsung atau tidak langsung melalui berbagai macam media dan metode serta berbagai macam peluang yang ada minimal sesuai target dan kesepakatan.
 - 2) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan komunitas berbasis Rumah Sakit dalam bentuk apapun baik di dalam gedung maupun diluar gedung sesuai rencana program masing-masing kelompok.

- 3) Mengumpulkan bahan untuk pembuatan metode dan media (leaflet/poster/materi) promosi, pendidikan, edukasi, informasi bagi komunitas
- 4) Membuat inovasi baru untuk kelompok pemberdayaan masyarakat yang lain.
- 5) Merekam/mencatat dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Pemberdayaan Komunitas berbasis RSPH Malang sesuai kelompok.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing kelompok pemberdayaan komunitas
- 7) Melaporkan semua kegiatan promosi, pendidikan, komunikasi, edukasi, informasi kesehatan melalui pemberdayaan komunitas dengan macam-macam metode dan media kepada Ketua PKRS setiap bulan dan rekapan setahun.

2. Anggota Bidang Pemberdayaan Komunitas Berbasis RSPH

a. Nama Jabatan : Anggota Pokja Pemberdayaan Komunitas Berbasis RSPH

b. Persyaratan Jabatan minimal :

- 1) D3 Kesehatan terutama D3 Promosi Kesehatan
- 2) Berpengalaman di bidang Promosi/penyuluhan minimal selama 3 bulan.
- 3) Mempunyai sertifikat pelatihan komunikasi efektif
- 4) Mempunyai Sertifikat Diklat PKRS tingkat terampil

c. Uraian Tugas Anggota

- 1) Membuat program kerja kegiatan Pokja Pemberdayaan Komunitas Berbasis RSPH melalui berbagai macam kegiatan, media dan metode serta berbagai macam peluang yang ada minimal sesuai target dan kesepakatan dengan komunitas sesuai dengan binaan masing masing.
- 2) Melaksanakan kegiatan Pembinaan Komunitas dalam bentuk apapun baik di dalam gedung maupun diluar gedung sesuai rencana program pokja komunitas berbasis RSPH.
- 3) Mengumpulkan bahan untuk pembuatan media dan metode (leaflet/ poster/ materi) promosi, pendidikan, edukasi, informasi bagi komunitas dalam bentuk apapun melalui berbagai macam media dan metode promosi yang diserahkan kepada Bidang sarana, prasarana dan media-metode PKRS .
- 4) Merekam/mencatat dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Pemberdayaan Komunitas sesuai kelompok (UMANDOK)
- 5) Memonitor rujukan edukasi dan rujukan balik edukasi ke komunitas atau pelayanan kesehatan tingkat pertama
- 6) Melaporkan semua kegiatan pemberdayaan Komunitas berbasis RSPH kepada Ketua PKRS.

3.2.3 Bidang SDM (pemeriksaan Kes dan peningkatan SDM)

a. Nama Jabatan : Ketua Bidang SDM PKRS

b. Persyaratan Jabatan minimal :

- 1) Sarjana (S1) Pendidikan, minimal D3 Kesehatan diutamakan dokter
- 2) Berpengalaman di bidang SDM minimal selama 6 bulan.
- 3) Mempunyai sertifikat pelatihan komunikasi efektif
- 4) Mempunyai Sertifikat Diklat PKRS tingkat terampil

c. Uraian Tugas Ketua Bidang SDM

- 1) Menyusun dan mengkoordinir rencana kegiatan pelatihan, bimbingan teknik, peningkatan SDM yang lain dan juga pemeriksaan kesehatan karyawan.
- 2) Mengkoordinir pengumpulan bahan dan bersama anggota membuat materi, naskah, form, untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, peningkatan SDM di bidang PKRS dan Komunikasi Efektif.

- 3) Mengkoordinasikan kepentingan pemeriksaan kesehatan karyawan dan peningkatan SDM untuk PKRS dengan semua unit/instalasi/ruangan
- 4) Mengkoordinir Nara Sumber dan peserta yang ikut peningkatan SDM dan juga pemeriksaan kesehatan karyawan
- 5) Mengkoordinasikan dengan ketua dan bidang lain untuk semua kebutuhan dan kegiatan pendidikan pelatihan edukator atau karyawan di masing masing unit.
- 6) Melakukan asesmen karyawan sebagai bahan perencanaan upaya preventif dan pemeriksaan dan peningkatan Kesehatan Karyawan.
- 7) Mengkoordinir tiap unit untuk pelaksanaan sosialisasi semua program Promosi Kesehatan Rumah Sakit kepada karyawan.
- 8) Melakukan koordinasi dengan Komite K3 RS untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan dari seluruh ruangan, unit atau instalasi secara bertahap
- 9) Mendokumentasikan semua kegiatan pemeriksaan kesehatan karyawan dan peningkatan SDM.
- 10) Melakukan upaya preventif atau kegiatan preventif bagi karyawan (Olah raga konseling, seminar, peningkatan ketrampilan, out-bond, rekreasi dll)
- 11) Melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan promosi/pendidikan/edukasi kesehatan melalui media massa. kepada ketua PKRS baik bulanan maupun tahunan.
- 12) Melaporkan kegiatan pemeriksaan kesehatan karyawan dan peningkatan SDM secara rutin tiap bulan dan juga tahunan kepada ketua Tim PKRS

3.2.4 Bidang Sarana, Prasarana, Media & Metode PKRS

1. Ketua

a. Nama Jabatan : Ketua Bidang Sarana, Prasarana, Media & Metode PKRS

b. Persyaratan Jabatan minimal :

- 1) Sarjana (S1) ekonomi, minimal D3 Kesehatan
- 2) Berpengalaman dalam pengelolaan Sarana Prasarana minimal 6 bulan.
- 3) Mempunyai sertifikat pelatihan komunikasi efektif
- 4) Mempunyai Sertifikat Diklat media PKRS

c. Uraian Tugas Ketua Bidang Sarana, Prasarana, Media & Metode PKRS

- 1) Mengumpulkan bahan dan membuat rancangan materi /naskah untuk promosi, pendidikan, komunikasi, edukasi, informasi melalui komunitas , di dalam dan di luar gedung, baik langsung maupun tidak langsung melalui media dan metode sesuai dengan asesmen pasien serta masyarakat.
- 2) Membuat, mendisain, mengedit dan mengusulkan materi promosi, pendidikan, edukasi, informasi kepada pasien dan keluarga ataupun komunitas serta masyarakat yang diusulkan oleh bidang lain ataupun usulan dari PKRS Unit baik cetak (Leaflet, brosur, booklet, lembar balik, Poster, Banner dll) maupun Non cetak .(visual, audio, audiovisual)
- 3) Mengelola & menginventarisasi peralatan/media/barang/bahan milik PKRS.
- 4) Mempersiapkan sarana prasarana atau perlengkapan kegiatan pelayanan promosi, pendidikan, edukasi, informasi, Bimtek, Diklat PKRS, melalui berbagai macam media dan metode secara inovatif dan kreatif.
- 5) Mengkoordinir penyiapan media (Sound, mike, kabel, LCD, Laptop, Flip Chard, alat peraga, media cetak, kain rentang dan kelengkapannya untuk kebutuhan promosi, pendidikan, edukasi, informasi kesehatan baik individu, kelompok atau massa, di dalam ataupun di luar Gedung.
- 6) Mengkoordinir penyiapan tempat, fasilitas (*lay-Out*) dan kebersihannya untuk promosi, pendidikan, edukasi, informasi kesehatan baik kelompok atau massa baik di dalam ataupun di luar Gedung

- 7) Mengkoordinir penyiapan mebelair (meja, kursi, dan kelengkapannya) untuk promosi, pendidikan, edukasi, informasi kesehatan baik kelompok ataupun massa, di dalam ataupun di luar Gedung.
- 8) Mengkoordinir penyiapan transportasi untuk promosi, pendidikan, edukasi, informasi kesehatan baik kelompok, massa, kegiatan komunitas di dalam ataupun di luar Gedung.
- 9) Melakukan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan pembuatan media, inventarisasi alat peralatan, sarana prasarana PKRS baik bulanan maupun tahunan.
- 10) Melaporkan seluruh kegiatan bidang sarana prasarana serta media secara rutin tiap bulan dan juga tahunan kepada ketua Tim PKRS

2. Anggota Bidang Sarana-Prasarana, Media dan Metode PKRS

a. Nama Jabatan : Anggota Bidang Sarana-Prasarana, Media dan Metode PKRS

b. Persyaratan Jabatan minimal :

- 1) S1 Multi Media / Sarjana Kesehatan Masyarakat /D3 Kesehatan/Komunikasi
- 2) Berpengalaman di bidang media minimal selama 3 bulan.
- 3) Mempunyai Sertifikat Pelatihan komunikasi Efektif
- 4) Mempunyai Sertifikat Diklat PKRS
- 5) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan computer khususnya MW, Exel, Pdf (*design grafis*) untuk membuat media cetak.
- 6) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan Tustel dan handicamp.
- 7) Mempunyai ketrampilan mengelola medsos (WA, Webb, Instagram, Radio, dll)
- 8) Dapat membuat audio, audio visual untuk KIE

c. Uraian tugas Anggota :

- 1) Membantu ketua mencari bahan dan membuat rancangan materi /naskah untuk promosi, pendidikan, komunikasi, edukasi, informasi untuk semua sasaran PKRS, di dalam dan di luar gedung, baik langsung maupun tidak langsung melalui media dan metode sesuai dengan asesmen pasien serta asesmen masyarakat.
- 2) Membantu ketua untuk *mendisign*, mengedit materi promosi, pendidikan, edukasi, informasi kepada pasien dan keluarga ataupun komunitas serta masyarakat yang diusulkan oleh bidang lain ataupun usulan dari PKRS Unit baik cetak (Leaflet, brosur, booklet, lembar balik, Poster, Banner dll) maupun Non cetak .(visual, audio, audiovisual)
- 3) Membantu ketua dalam melaksanakan promosi, pendidikan, edukasi, informasi kesehatan untuk semua sasaran melalui audio, audio visual, media sosial dan media cetak .
- 4) Mencatat, mendokumentasikan, mengarsipkan semua hasil kegiatan bidang Sarana-Prasarana, Media dan Metode PKRS
- 5) Membantu ketua menyiapkan media (Sound, mike, LCD, kabel, dan kelengkapannya) untuk kebutuhan penyuluhan/promosi/ pendidikan/informasi kesehatan kelompok /massa baik di dalam ataupun di luar Gedung.
- 6) Membantu ketua menyiapkan tempat dan kebersihannya serta mebelair untuk promosi, pendidikan, komunikasi, edukasi, informasi kesehatan kelompok /massa baik di dalam ataupun di luar Gedung
- 7) Membantu menyiapkan mebelair (meja, kursi, dan kelengkapannya) untuk promosi, pendidikan, komunikasi, edukasi, informasi di dalam ataupun di luar Gedung.
- 8) Memasang Poster/spanduk/banner/acessoris background semua media

cetak dan non cetak ditempat promosi, pendidikan, komunikasi, edukasi, informasi kesehatan sesuai sasaran di dalam ataupun di luar Gedung.

- 9). Mengamankan seluruh sarana dan prasarana serta mengamankan jalannya pelaksanaan pemberian promosi, pendidikan, komunikasi, edukasi, informasi kepada sasaran.
- 10) Membantu membuat laporan semua kegiatan bidang Sarana-Prasarana, Media dan Metode PKRS

3.3 Dukungan Manajemen

Peran Direktur Rumah Sakit

1. Mendorong dan menjamin implementasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit secara terintegrasi dalam organisasi;
2. Menjamin berlangsungnya kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
3. Menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan program Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
4. Mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja Promosi Kesehatan Rumah Sakit; dan
5. Mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusi setiap unsur dalam meningkatkan kinerja Promosi Kesehatan Rumah Sakit.
6. Anggaran Dana

3.4 Pengembangan/Pendidikan

Rumah sakit mempunyai program pelatihan komunikasi efektif untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk pimpinan rumah sakit serta semua staf yang terlibat. Staf yang berada di unit kerja maupun di tim PKRS memerlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Pelatihan staf perlu direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan peran staf dalam program PKRS. Rumah sakit mengidentifikasi dan menyediakan pelatih kompeten untuk pendidikan dan pelatihan ini. Kompeten di sini, yaitu pelatih tersebut pernah mengikuti pelatihan/ workshop peningkatan mutu PKRS. Agar Profesional Pemberi Asuhan (PPA) mampu memberikan edukasi secara efektif dilakukan pelatihan sehingga terampil melaksanakan komunikasi efektif. Pengetahuan tentang materi yang diberikan dan kemampuan berkomunikasi secara efektif adalah pertimbangan penting dalam edukasi yang efektif.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN

4.1 Monitoring

Pembinaan dalam upaya kesinambungan PKRS merupakan tugas manajemen rumah sakit, pembinaan dilaksanakan dengan mengadakan rapat setiap bulan dan triwulan. Hasil kegiatan dijadikan masukan dalam mengevaluasi kegiatan PKRS. Pembinaan hendaknya dilakukan terhadap perkembangan dari masukan (input), proses, dan keluaran (output), dengan menggunakan indikator-indikator tertentu.

Kegiatan monitoring PKRS antara lain mencakup pengamatan tentang:

- a. apakah kebijakan sudah tersosialisasi pada seluruh sasaran, pedoman/panduan/prosedur kerja (SPO) dimengerti dan sudah sesuai dengan sasaran;
- b. asesmen Pasien apakah sudah dilaksanakan dan dicatat pada rekam medis;
- c. materi komunikasi apakah sudah memuat secara detail sesuai dengan sasaran, mudah dipahami, dan kecukupan media apakah tersedia seperti poster, lembar balik, leaflet, media luar ruang, media elektronik, dan sebagainya.
- d. kegiatan edukasi seperti konseling, penyuluhan kelompok, penyuluhan massa, diskusi kelompok, kunjungan rumah dan lain sebagainya, frekuensi dan waktu pelaksanaannya apakah sudah mencukupi.
- e. kecukupan tenaga dan pelatihan apakah sudah sesuai dengan jumlah sasaran. Selama intervensi diamati reaksi sasaran seperti efektivitas pelaksanaan, target sasaran tidak mengerti, kejenuhan terhadap pesan atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai maka dilakukan perbaikan-perbaikan

4.2 Evaluasi

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, standar, peraturan dan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Pengendalian merupakan metode atau alat melakukan kontrol terhadap input proses dan output pelayanan agar tetap sesuai dengan arah yang ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian bertujuan agar semua kegiatan-kegiatan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan sesuai dengan tujuan, rencana, pembagian tugas, rumusan kerja, pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian pelayanan PKRS adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dan pelaporan merupakan alat untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan adapun bentuk – bentuk pencatatan dan pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Formulir edukasi terintegrasi
- b. Laporan kegiatan Edukasi Kelompok
- c. Laporan bulanan kepada direktur RS.

2. Kegiatan Pertemuan/ Rapat Koordinasi

a. Rapat Rutin

Rapat internal Tim PKRS dilakukan pada minggu pertama tiap 1 bulan sekali. Rapat ini dihadiri oleh seluruh tim PKRS untuk membahas permasalahan internal ataupun eksternal, koordinasi internal, keilmuan, dan lain-lain.

b. Rapat Triwulan

Rapat internal Tim PKRS dilakukan pada minggu pertama tiap 3 bulan sekali. Rapat ini dihadiri oleh seluruh tim PKRS untuk membahas laporan kegiatan yang sudah dilakukan dalam 3 bulan.

c. Rapat Insidentil

Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas dan sosialisasi kebijakan baru.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 September 2025
Ketua PKRS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Endy Wira Pradana'.

drg. Endy Wira Pradana, M.MRS